TUGAS TERSTRUKTUR: IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DAN KONTEKS ORGANISASI KLINIK

Nama: SOFI, FEMI

1. Profil Singkat Organisasi & Konteks Kasus

Klinik Sehat Bersama merupakan sebuah klinik kesehatan swasta yang melayani pemeriksaan umum, konsultasi dokter, tindakan medis, serta pelayanan obat. Saat ini, sebagian besar proses pelayanan di klinik masih berjalan menggunakan pencatatan manual dan aplikasi yang terfragmentasi (tidak saling terintegrasi). Kondisi ini memicu berbagai masalah operasional seperti antrean pasien yang panjang, pencarian riwayat/rekam medis pasien yang memakan waktu lama, serta penyusunan laporan manajemen yang terpisah dan tidak real-time.

Untuk mengatasi inefisiensi tersebut, manajemen klinik menginisiasi proyek pengembangan Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mencakup seluruh modul operasional mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, pemeriksaan dokter, tindakan medis, pengelolaan resep dan obat, pembayaran kasir, hingga laporan manajemen. Proyek ini dipimpin oleh Kepala Klinik dengan batasan (constraints) berupa anggaran yang terbatas, batas waktu implementasi yang ketat dari manajemen, serta tuntutan keamanan data pasien yang sangat tinggi.

2. Daftar Stakeholder, Peran, dan Analisis Power-Interest

No	Stakeholder	Power (1-5)	Interest (1-5)	Analisis / Argumentasi Kontekstual
1	Pemilik Klinik	5	4	Pemilik modal utama yang mendanai proyek secara makro. Memiliki otoritas tertinggi (Power 5) untuk melanjutkan atau menghentikan proyek demi pengembangan bisnis, namun tidak terlibat dalam detail operasional harian teknis sistem (Interest 4).
2	Kepala Klinik	5	5	Pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi operasional klinik sekaligus ketua proyek. Memiliki kuasa penuh mengambil keputusan internal (Power 5) dan berkepentingan sangat tinggi agar sistem mengintegrasikan proses bisnis

				secara menyeluruh demi kemudahan pelaporan manajemen (Interest 5).
3	Divisi IT Internal	4	5	Tim internal yang bertanggung jawab langsung atas implementasi, integrasi, pemeliharaan, serta keamanan data medis klinis. Memiliki power teknis operasional yang tinggi (Power 4) dan ketergantungan yang mutlak terhadap keberhasilan adopsi sistem baru (Interest 5).
4	Vendor Pengembang	4	3	Pihak ketiga penanggung jawab pembuatan produk perangkat lunak. Memiliki kendali teknis arsitektur sistem (Power 4), tetapi kepentingannya bersifat transaksional berbasis kontrak karena mereka membagi jadwal dengan proyek eksternal lain (Interest 3).
5	Petugas Keuangan / Kasir	4	3	Mengontrol dan mengawasi sirkulasi anggaran pengembangan yang terbatas. Memiliki power untuk menolak pengeluaran tambahan (Power 4) serta berkepentingan agar transaksi kasir tercatat akurat tanpa kecurangan, walau tidak memengaruhi alur medis (Interest 3).
6	Dokter	3	5	Pengguna klinis utama (key user) yang menentukan kesuksesan adopsi sistem. Jika dokter menolak memakai sistem, proyek dipastikan gagal. Memerlukan akses super cepat ke rekam medis elektronik (Power 3, Interest 5).
7	Perawat	2	4	Staf medis yang menginput detail tindakan medis dan kondisi pasien sehari-hari. Memiliki pengaruh kecil pada kebijakan (Power 2), tetapi sangat berkepentingan agar sistem mudah dipahami demi kelancaran tugas harian mereka (Interest 4).
8	Apoteker	2	4	Bertanggung jawab atas pengelolaan obat dan akurasi peresepan digital. Memiliki power rendah terhadap sistem (Power 2),

				namun interest tinggi karena keakuratan integrasi stok obat langsung berdampak pada efisiensi kerja mereka (Interest 4).
9	Petugas Pendaftaran	2	4	Garda depan pelayanan yang berinteraksi langsung dengan antrean pasien fisik. Power rendah (Power 2), namun sangat berkepentingan agar modul pendaftaran dapat mengurai antrean secara instan (Interest 4).
10	Pasien	1	5	Konsumen akhir dari pelayanan kesehatan klinik. Sama sekali tidak memiliki hak suara atau kontrol struktural terhadap pengembangan sistem (Power 1), namun sangat berkepentingan agar waktu tunggu menjadi cepat dan datanya aman (Interest 5).

3. Pemetaan Power–Interest Grid Matrix

Berikut merupakan representasi pemetaan visual 2x2 matriks penempatan 10 stakeholder berdasarkan kombinasi tingkat Power dan Interest:

KEEP SATISFIED (High Power - Low Interest) **• Vendor Pengembang (Power 4, Interest 3)** **• Petugas Keuangan / Kasir (Power 4, Interest 3)**	**MANAGE CLOSELY (High Power - High Interest)** **• Pemilik Klinik (Power 5, Interest 4)** **• Kepala Klinik (Power 5, Interest 5)** **• Divisi IT Internal (Power 4, Interest 5)**
MONITOR WITH MINIMUM EFFORT (Low Power - Low Interest) **• (Tidak ada stakeholder di kuadran ini berdasarkan analisis kasus khusus)**	**KEEP INFORMED / INVOLVE (Low Power - High Interest)** **• Dokter (Power 3, Interest 5)** **• Perawat (Power 2, Interest 4)** **• Apoteker (Power 2, Interest 4)** **• Petugas Pendaftaran (Power 2, Interest 4)** **• Pasien (Power 1, Interest 5)**

4. Strategi Pengelolaan & Komunikasi

- **Manage Closely (Kelola Secara Dekat):** Melakukan pertemuan koordinasi steering committee mingguan dengan Kepala Klinik dan Pemilik Klinik untuk melaporkan kemajuan proyek dan menyelaraskan dengan tujuan ekspansi bisnis. Berkolaborasi intensif setiap hari dengan Divisi IT internal untuk memantau implementasi modul keamanan data pasien dan kesiapan server.
- **Keep Satisfied (Jaga Kepuasan):** Menerapkan Service Level Agreement (SLA) yang formal pada kontrak Vendor Pengembang untuk memastikan disiplin timeline kerja di tengah kesibukan proyek lain. Menyediakan transparansi laporan keuangan berkala kepada Petugas Keuangan/Kasir agar pencatatan modul billing selaras dengan regulasi tanpa melampaui pagu anggaran.
- **Keep Informed (Libatkan & Komunikasi Rutin):** Melakukan Focus Group Discussion (FGD) rutin dengan perwakilan Dokter, Perawat, Apoteker, dan Petugas Pendaftaran guna mengumpulkan kebutuhan alur kerja riil. Menyediakan modul demo interaktif dan program pelatihan komprehensif untuk meminimalkan kecemasan masa adaptasi perubahan dari manual ke digital. Bagi pasien, sediakan infografis atau pemberitahuan transisi layanan di area ruang tunggu klinik.
- **Monitor (Cukup Dimonitor):** Memantau secara pasif pihak pendukung umum eksternal atau staf non-operasional inti. Memberikan pembaruan informasi minimal jika terjadi penyesuaian alur kerja makro.